

Projekt BENE-Plattform KSW

Meeting-Protokoll vom 25.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsinformationen	2
1. Teilnehmende	2
2. Zielsetzung der Sitzung.....	2
3. Besprochene Inhalte und Ergebnisse	3
3.1 Allgemeine Anpassungen der Webapplikation.....	3
3.2 Anpassungen der präoperativen Checkliste	3
3.3 Anpassungen des Gesamtpfads	5
3.4 Postoperativer Abschnitt.....	5
4. Offene fachliche und technische Fragen	5
5. Vereinbarte Folgeaufgaben	6
6. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen	6

Sitzungsinformationen

Digitale Unterstützung des perioperativen Patientenpfads

Sitzung: Projektbesprechung und Evaluation des Web-App-Prototyps
Datum: 25. September 2026
Zeit: 13:00–14:30 Uhr
Dauer: 90 Minuten
Partner: Kantonsspital Winterthur (KSW) und ZHAW

1. Teilnehmende

Name	Funktion / Organisation
Fabian Obrecht	Oberarzt, Klinik für Urologie, KSW
Corina Frei	Physician Associate, Klinik für Urologie, KSW
Thiago Braganca	Projektteam, ZHAW
Gökmen Erdem	Projektteam, ZHAW
Javier Montoya	Projektleiter und Betreuer, ZHAW

2. Zielsetzung der Sitzung

Ziel der Sitzung war die gemeinsame Durchsicht und Evaluation des aktuellen Prototyps der ERAS-Webapplikation. Im Mittelpunkt standen die Überprüfung der fachlichen Inhalte, die Besprechung bereits übermittelter Rückmeldungen des Kantonsspitals Winterthur sowie die Identifikation notwendiger Anpassungen und zusätzlicher Funktionalitäten.

Insbesondere sollte sichergestellt werden, dass das Projektteam die medizinischen Anforderungen und die Abläufe des perioperativen Patientenpfads korrekt verstanden und im Prototyp entsprechend abgebildet hat.

Die Sitzung verfolgte folgende Ziele:

- Gemeinsame Durchsicht des bestehenden Prototyps.
- Plausibilisierung und Konkretisierung der bereits erhaltenen Rückmeldungen.
- Überprüfung der fachlichen Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte.
- Klärung offener Fragen bezüglich der prä-, intra- und postoperativen Abläufe.
- Identifikation zusätzlicher Anforderungen und Optimierungsmöglichkeiten.
- Festlegung der nächsten Arbeitsschritte.

3. Besprochene Inhalte und Ergebnisse

Der Prototyp wurde gemeinsam mit den Teilnehmenden durchgegangen. Die einzelnen Checklistenpunkte wurden hinsichtlich Inhaltes, Funktionalität und Benutzerführung besprochen. Aus der Besprechung ergaben sich die nachfolgend dokumentierten Anpassungen und Ergänzungen.

3.1 Allgemeine Anpassungen der Webapplikation

3.1.1 Pflichtfelder und Checklistenlogik

Grundsätzlich sollen sämtliche Checklistenpunkte verpflichtend bearbeitet und explizit abgehakt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle relevanten Punkte des perioperativen Patientenpfads bewusst durchgegangen werden.

Eine Ausnahme bildet die Suchtmittelanamnese: Die inhaltlichen Angaben sind hier nicht verpflichtend auszufüllen.

3.1.2 Visuelle Validierung

Für die Rückmeldung bei Eingaben sollen verstärkt Farbindikatoren eingesetzt werden.

- Grün: erfolgreiche beziehungsweise gültige Eingabe.
- Rot: ungültige Eingabe oder Überschreitung eines definierten Grenzwerts.

Dadurch sollen Eingabefehler und auffällige Werte unmittelbar erkennbar sein.

3.1.3 Verhalten abgeschlossener Checklistenpunkte

Nach dem Abhaken eines Checklistenpunkts sollen die zugehörigen Eingabefelder automatisch eingeklappt werden. Aktuell bleiben die Eingabefelder auch nach dem Abschluss geöffnet, wodurch der Eindruck entstehen kann, dass weitere Eingaben erforderlich sind.

3.1.4 Archivierung von Behandlungsfällen

Abgeschlossene Behandlungsfälle sollen archiviert werden können. In der Patientenübersicht soll ein gut sichtbarer Button «Archivierte Fälle» ergänzt werden, über den bereits archivierten Fällen wieder aufgerufen werden können.

3.1.5 Entfernung nicht benötigter Punkte

Der bisherige Checklistenpunkt «KISIM-Pfad» soll entfernt werden.

3.2 Anpassungen der präoperativen Checkliste

3.2.1 Vitalparameter

Im Bereich der Vitalparameter soll zusätzlich eine automatische Berechnung des Body-Mass-Index (BMI) implementiert werden. Die Berechnung erfolgt anhand der erfassten Körpergröße und des Körpergewichts.

3.2.2 G8-Score und Geriatrie

Beim G8-Score soll bei Erreichen eines fachlich definierten Grenzwerts eine entsprechende Zuweisung zur Geriatrie ausgelöst beziehungsweise als erforderliche Massnahme angezeigt werden. Der konkrete Schwellenwert und die dazugehörige Entscheidungsregel sind bei der Implementierung nochmals fachlich zu bestätigen.

3.2.3 Labor inklusive Patient Blood Management (PBM)

Für die Erfassung der Laborwerte wurde eine mögliche Erweiterung diskutiert. Laborbefunde aus KISIM sollen idealerweise mittels Drag-and-drop in die Webapplikation eingefügt werden können. Anschliessend sollen die enthaltenen Werte beispielsweise mithilfe von Optical Character Recognition (OCR) automatisch erkannt und in die entsprechenden Eingabefelder übernommen werden.

Die bisherige manuelle Eingabemöglichkeit soll weiterhin bestehen bleiben, damit Werte bei Bedarf ergänzt oder korrigiert werden können. Die technische Machbarkeit und der konkrete Umsetzungsumfang sind noch zu prüfen.

3.2.4 Kardiologische Abklärung

Beim Checklistenpunkt «Überprüfung Zuweisung Kardiologie gemäss Weisung «Präoperative kardiologische Abklärung»» soll der bereits zuvor erfasste mMRC-Wert automatisch übernommen werden.

Damit soll eine doppelte Dateneingabe vermieden werden.

3.2.5 Zuweisungen und Arbeitsliste

Die verschiedenen Zuweisungen sollen am Ende der Checkliste in einer übersichtlichen Arbeitsliste zusammengeführt werden.

Dabei soll der jeweilige Bearbeitungsstatus ersichtlich sein, beispielsweise:

- Zuweisung erforderlich.
- Zuweisung erfolgt.
- Termin beziehungsweise Datum noch ausstehend.
- Zuweisung abgeschlossen.

Dadurch sollen offene Aufgaben und noch ausstehende Abklärungen zentral dargestellt werden.

3.2.6 Automatisierte Textbausteine für Zuweisungen

Für Zuweisungen sollen vorgefertigte Textbausteine bereitgestellt werden. Diese sollen bereits vorhandene Informationen wie Patientenname, Untersuchungsergebnisse und weitere relevante Angaben automatisch übernehmen. Der generierte Text soll kopiert und anschliessend beispielsweise in KISIM zur Erstellung einer entsprechenden Verordnung oder Zuweisung verwendet werden können.

3.2.7 Physiotherapie

Für die Anmeldung zur Physiotherapie soll ebenfalls ein entsprechender Textbaustein ergänzt werden. Dieser war in der bisherigen Word-Vorlage noch nicht enthalten.

3.3 Anpassungen des Gesamtpfads

Im Fenster «Gesamtpfad» wurden folgende Anpassungen besprochen:

Bereich	Vereinbarte Anpassung
BENE-Nurse	Punkt «BENE-Nurse informieren» entfernen
Anästhesiologie	Bereits erfasste Informationen aus dem ersten Pfad übernehmen
Physiotherapie	Daten aus der ersten BENE-Sprechstunden-Checkliste übernehmen
Ernährungsberatung	Bereits erfasste Informationen übernehmen
Stomaberatung	Anstelle der Anzahl soll ein Datum erfasst werden
Stomaberatung	Punkt «Fakultatives Treffen» entfernen

Ziel dieser Anpassungen ist es, bereits vorhandene Informationen innerhalb des Gesamtpfads wiederzuverwenden und unnötige Mehrfacheingaben zu vermeiden.

3.4 Postoperativer Abschnitt

3.4.1 Struktur der stationären postoperativen Checkliste

Die derzeit übergeordneten Punkte im Abschnitt «Postoperativ stationär» sollen als Abschnittstitel dienen. Die jeweiligen Unterpunkte müssen einzeln abgehakt werden können. Dadurch soll eine detailliertere Dokumentation der tatsächlich durchgeführten Massnahmen ermöglicht werden.

3.4.2 Entfernung eines nicht mehr benötigten Punkts

Im zweiten operativen Abschnitt soll der Punkt «Instruktion Fragmin» entfernt werden, da dieser nicht mehr benötigt wird.

4. Offene fachliche und technische Fragen

Im Rahmen der Sitzung konnten nicht alle Inhalte abschliessend geklärt werden. Insbesondere der intraoperative Abschnitt des Gesamtpfads bedarf weiterer fachlicher Abklärungen. Der vollständige Gesamtpfad wird deshalb nochmals als PDF an das Kantonsspital Winterthur übermittelt. Die zuständigen Fachpersonen werden die Inhalte erneut prüfen und dem Projektteam weitere Rückmeldungen zukommen lassen.

Darüber hinaus bleiben folgende Punkte zur weiteren Klärung offen:

Thema	Offene Frage
Intraoperativer Ablauf	Welche Inhalte und Prozessschritte müssen im Gesamtpfad abgebildet werden?
Laborimport	Wie kann ein automatisierter Import aus KISIM technisch umgesetzt werden? (Input: OCR)
ICT-Anbindung	Welche technischen und organisatorischen Anforderungen gelten für eine spätere Anbindung an die Spitalinfrastruktur?

5. Vereinbarte Folgeaufgaben

Nr.	Aufgabe	Zuständigkeit
1	Besprochene Anpassungen und Ergänzungen in den Prototyp übernehmen	ZHAW-Projektteam
2	Gesamtpfad erneut als PDF an das KSW übermitteln	ZHAW-Projektteam
3	Gesamtpfad fachlich prüfen und weitere Rückmeldungen geben	KSW
4	Offene Fragen zum intraoperativen Ablauf klären und das weitere Vorgehen kommunizieren	KSW
5	Erste Kontaktaufnahme mit der ICT-Abteilung bezüglich einer möglichen Anbindung initiieren	KSW
6	Technische Machbarkeit des automatisierten Laborimports untersuchen	ZHAW-Projektteam
7	Zusätzliche Textbausteine für Zuweisungen und Physiotherapie vorbereiten	ZHAW-Projektteam
8	Checklistenlogik, Pflichtfelder, Fortschrittsdarstellung und Archivierung entsprechend anpassen	ZHAW-Projektteam

Für die Aufgaben wurden im Rahmen der vorliegenden Sitzungsnotizen keine konkreten Abschlussfristen festgehalten (Richtwert Ende Oktober).

6. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

- Die gemeinsame Durchsicht des Prototyps ermöglichte eine vertiefte Abstimmung zwischen dem ZHAW-Projektteam und den medizinischen Fachpersonen des Kantonsspitals Winterthur.
- Die fachlichen Rückmeldungen führten zu konkreten Anpassungen der bestehenden Checklisten sowie zu zusätzlichen Anforderungen hinsichtlich Benutzerführung, Datenübernahme, Zuweisungsmanagement und Archivierung.
- Ein wesentlicher Schwerpunkt der weiteren Entwicklung liegt auf der Reduktion mehrfacher Dateneingaben und einer übersichtlichen Darstellung offener Massnahmen innerhalb des perioperativen Patientenpfads.
- Der Gesamtpfad wird dem KSW erneut zur fachlichen Prüfung zugestellt. Insbesondere der intraoperative Abschnitt bleibt bis zur entsprechenden Rückmeldung noch offen.
- Parallel dazu werden die besprochenen Anpassungen im Prototyp umgesetzt und die ersten Schritte für eine mögliche ICT-Anbindung über Fabian Obrecht eingeleitet.